

Inevitable abortion

Documento de origen: ABORTO.pdf

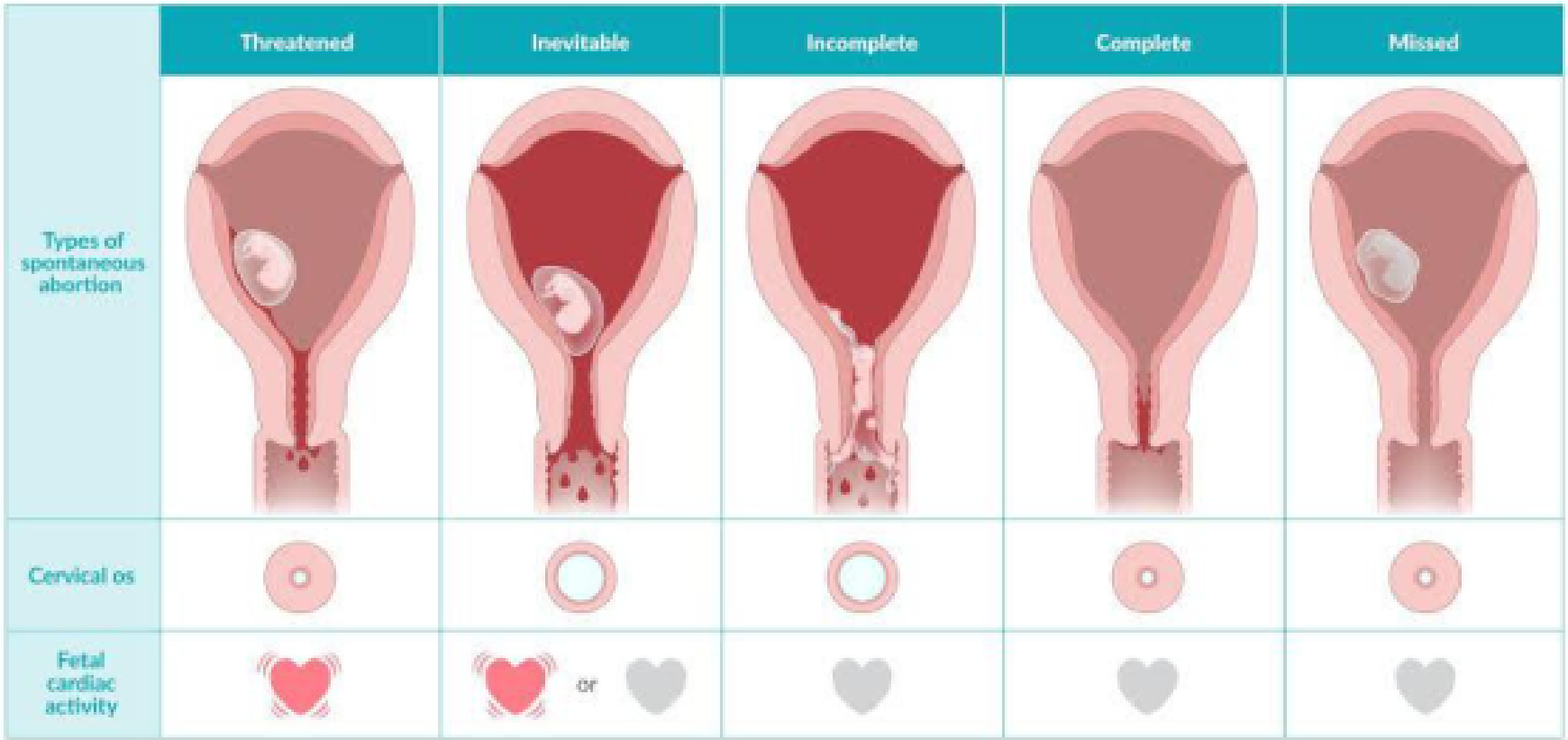


Imagen 2/29: ABORTO.pdf-0003-04.png

Documento de origen: ABORTO.pdf

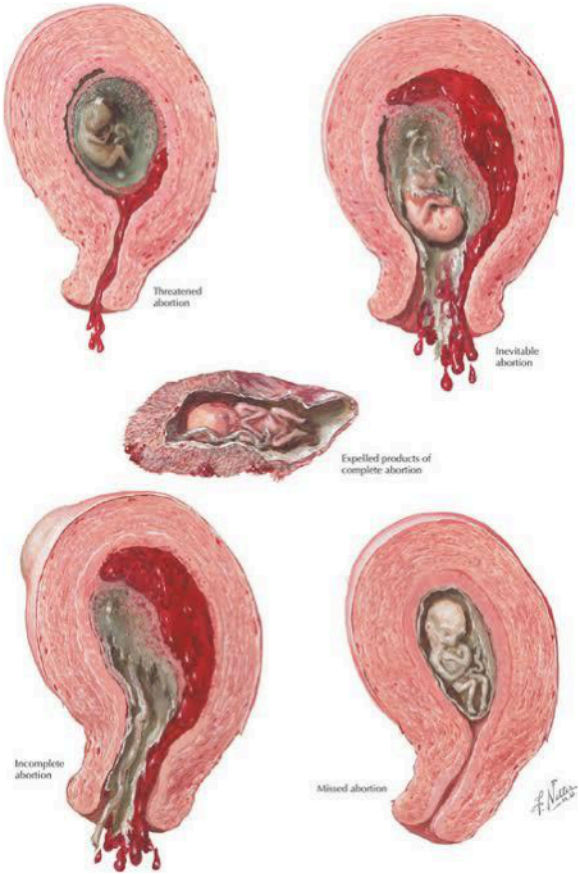


Imagen 3/29: ABORTO.pdf-0003-06.png

Documento de origen: ABORTO.pdf

Cuadro 2. ETAPAS CLÍNICAS DE LA AMENAZA DE ABORTO

Etapas / Diagnóstico	Amenaza de aborto 
Metrorragia	Oscura y escasa
Contracciones uterinas dolorosas	Presentes
Modificaciones cervicales	Cuello cerrado
Desprendimiento y expulsión	Ausentes
Ecografía	Hemorragia decidual Coágulo subcorial Embrión vivo intrauterino

GPC SS-280-026. Intervenciones de enfermería para la detección oportuna y limitación del daño por amenaza de aborto en los tres niveles de atención; *Fescina, De Lucio, Diaz Rosello, et al. 2011. Salud sexual y reproductiva. Guías para el continuo de la atención de la mujer y de la niñez focalizada en APS. 3ª edición. Montevideo. CLAP/SmR.*

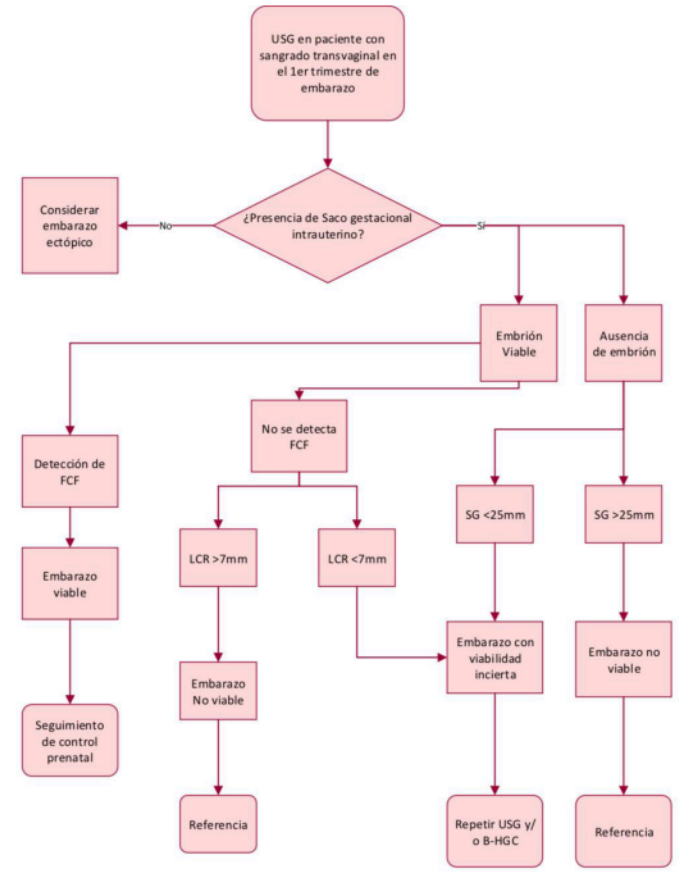
Diagnostico diferencial

Imagen 4/29: ABORTO.pdf-0005-00.png

Documento de origen: ABORTO.pdf

gnostico diferencial

nóstico



Tratamiento

Imagen 5/29: ABORTO.pdf-0005-01.png

Documento de origen: ABORTO.pdf

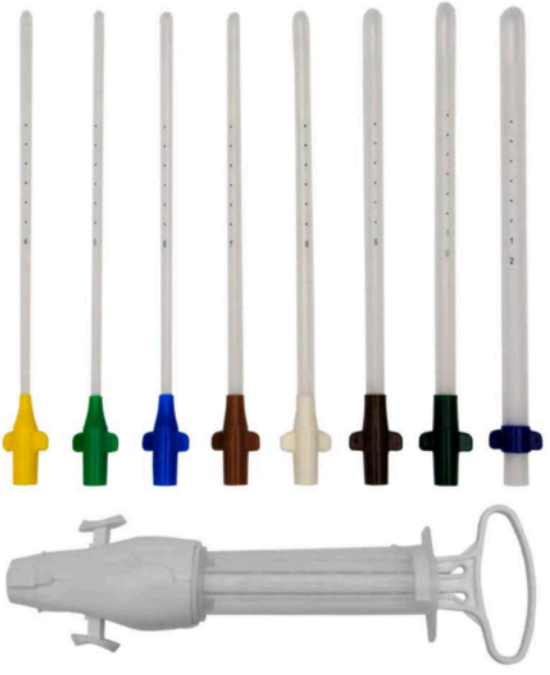
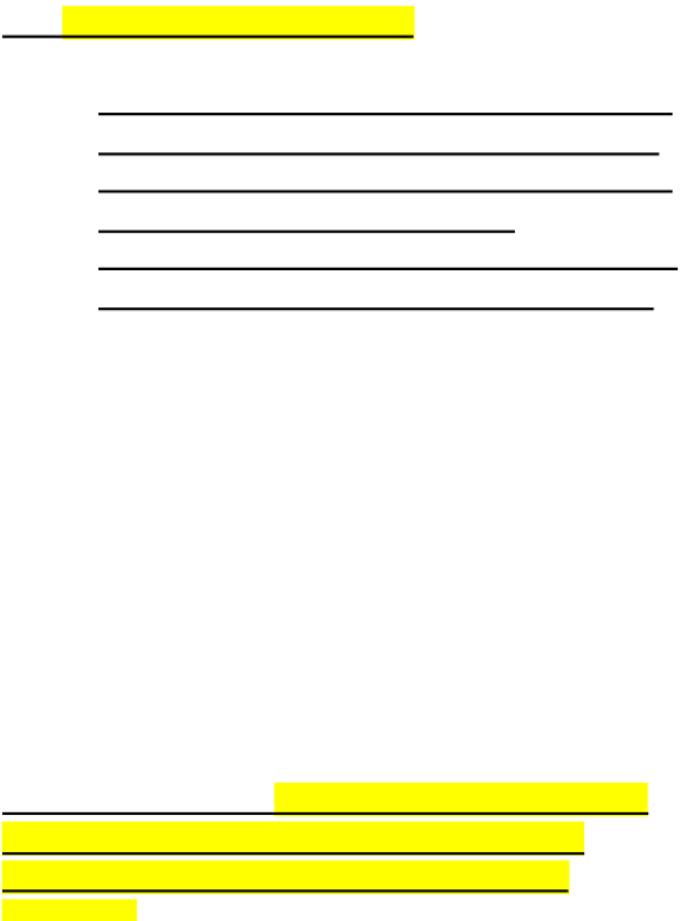


Imagen 6/29: ABORTO.pdf-0008-01.png



Documento de origen: ABORTO.pdf

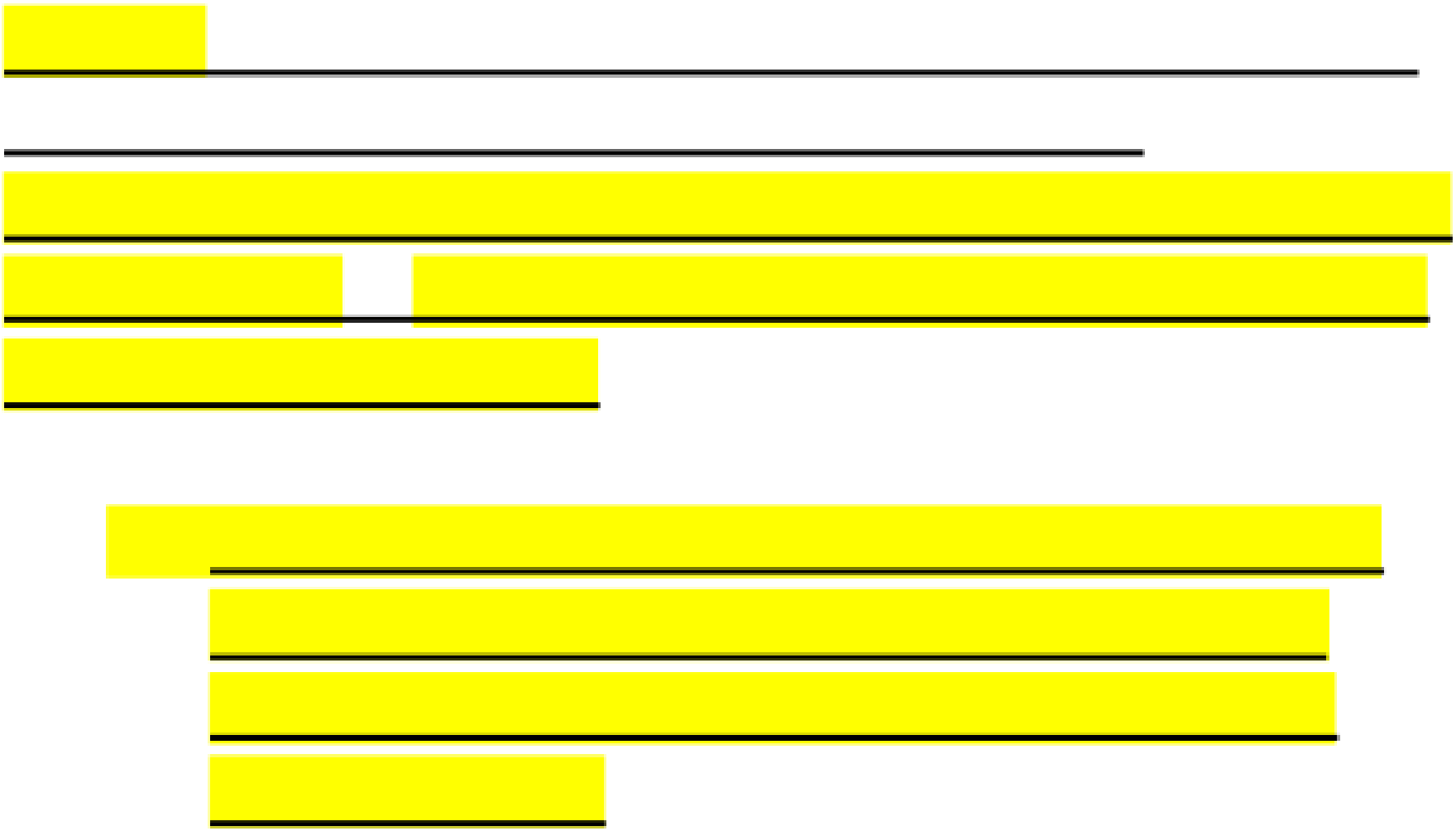


Imagen 8/29: ABORTO.pdf-0009-03.png

Documento de origen: ABORTO.pdf

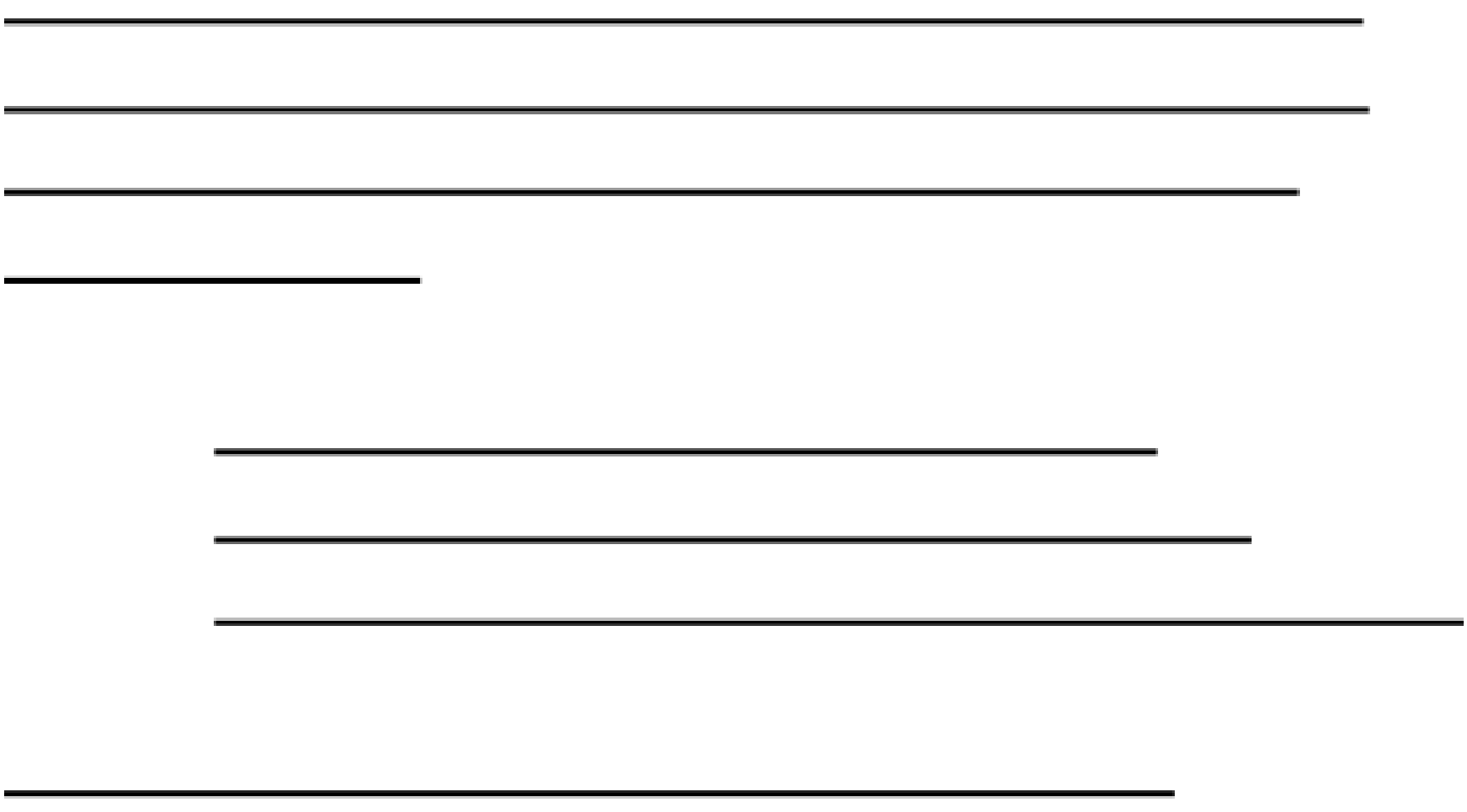


Imagen 9/29: ABORTO.pdf-0010-00.png

Documento de origen: ABC



Imagen 10/29: ABORTO.pdf-0

Documento de origen: GPC Amenaza de aborto.pdf

	La suplementación con vitamina A y C no ayudan a prevenir el aborto espontaneo.	**Fuerte** **GRADE** *Balogun O, 2016*
	El aborto espontáneo se ha asociado con el aumento de los niveles de angustia, ansiedad y depresión. Clifford y otros (1997), encontraron que las mujeres embarazadas que seguían un plan específico de apoyo de asesoramiento prenatal tenían una tasa de éxito del embarazo significativamente más alta que las que no participaron.	**2++** **NICE** *San Lázaro I, 2017*
	Proporcionar a todas las mujeres información y apoyo de una manera sensible, tomando en cuenta sus circunstancias personales y respuestas emocionales.	**B** **NICE** *San Lázaro I, 2017*
	La obesidad tiene un gran impacto en la fertilidad femenina, ya que está relacionada no solo con la pérdida gestacional, sino también con la infertilidad conyugal.	**2++** **NICE** *Cavalcante M, 2018*
	Cada consulta prenatal debe tener una estructura y un enfoque. Las primeras consultas en el embarazo deben ser extensas para proporcionar información y tiempo para la discusión acerca del cribado y la toma de decisiones informadas.	**A** **NICE** *NICE 62, 2019*
	La consulta de control prenatal (idealmente a las diez semanas), debe incluir detecciones y pruebas encaminadas a: • Identificar a las mujeres que necesitan cuidados adicionales y el plan de atención para el embarazo • Medir altura, peso y calcular el índice de masa corporal • Comprobar, por medio del análisis de sangre, el tipo de grupo sanguíneo, el estado RhD, así como detectar anemia, hemoglobinopatías, aloanticuerpos de glóbulos rojos, el virus de la hepatitis B, el VIH, susceptibilidad a la rubéola y sífilis	**A** **NICE** *NICE 62, 2019*

Imagen 11/29: GPC_Amenaza_de_aborto.pdf-0014-01.png

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos 1° y 4°

Tratados o Acuerdos Internacionales referentes a derechos humanos:

- Convención Americana sobre Derechos Humanos
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará)
- Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Convención sobre los Derechos del Niño
- Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo)
- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
- Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
- Declaración de Nairobi sobre la CIPD25

Ley General de Salud. Artículos 1, 10 bis, 27 fracción IV y V, 37, 61, 67

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 18

Ley General de Víctimas. Artículos 29, 30, 35

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, Capítulo IX Bis

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 50

Acción de Inconstitucionalidad 148/2017
Acción de Inconstitucionalidad 106/2018 y su Acumulada 107/2018
Acción de Inconstitucionalidad 54/2018
Controversias Constitucionales 45/2016 y 53/2016
Acciones de Inconstitucionalidad 41/2019 y su acumulada 42/2019

NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. Apartados 2, 6.4.2.7, 6.4.2.8

NOM-047-SSA2-2015. Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad. Apartados 6.8.9, 6.8.10, 6.8.11

Leyes de salud estatales

Códigos penales estatales y Código Penal Federal


Autonomía Reproductiva
Imprudencial/ Accidental
Violencia sexual
Inseminación artificial no consentida
Peligro de muerte
Daño a la salud
Alteraciones genéticas o congénitas del producto
Causas económicas
PROTECCIÓN A LA SALUD INTEGRAL

Documento de origen: Lineamientos aborto.pdf

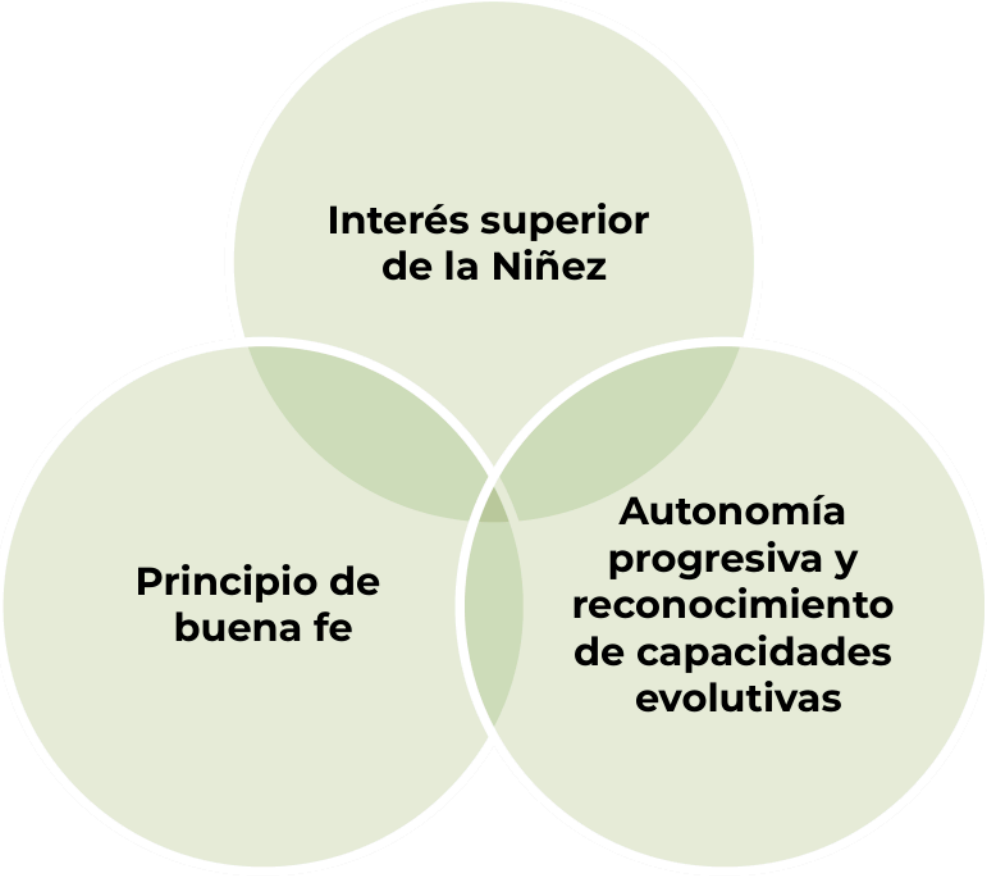


Imagen 14/29: Lineamientos_aborto.pdf-0041-05.png

Documento de origen: Lineamientos aborto.pdf



Imagen 15/29: Lineamientos_aborto.pdf-0070-00.png

Documento de origen: Lineamientos aborto.pdf



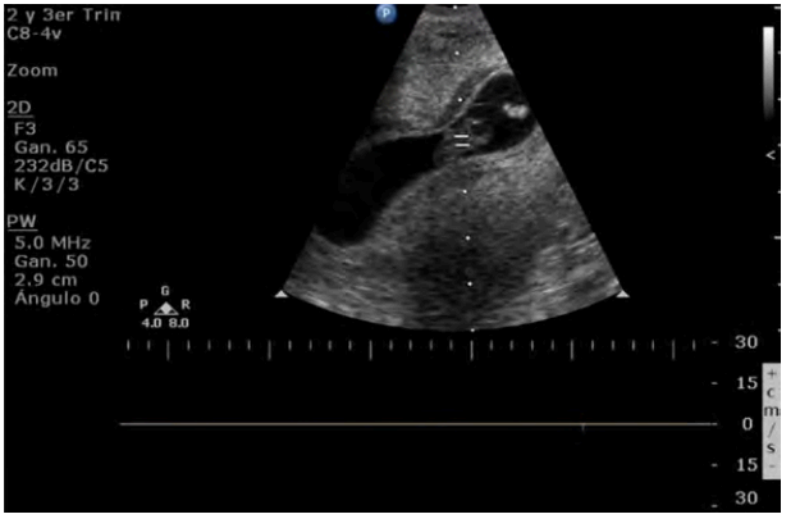
Imagen 16/29: Lineamientos_aborto.pdf-0070-01.png

Documento de origen: Lineamientos aborto.pdf



Imagen 17/29: Lineamientos_aborto.pdf-0071-00.png


C8-4v
69Hz
5cm
2D
F3
Gan. 41
232dB/C5
G/3/3
G
P R
4.0 8.0
CERVIX


2 y 3er Trin
C8-4v
Zoom
2D
F3
Gan. 65
232dB/C5
K/3/3
PW
5.0 MHz
Gan. 50
2.9 cm
Ángulo 0
G
P R
4.0 8.0
30
15
0
15
30
cm/s

Documento de origen: Lineamientos aborto.pdf



Imagen 19/29: Lineamientos_aborto.pdf-0072-03.png

Documento de origen: Linear



Imagen 20/29: Lineamientos_abc

Documento de origen: L



Imagen 21/29: Lineamiento

Documento de origen: Lineamientos aborto.pdf

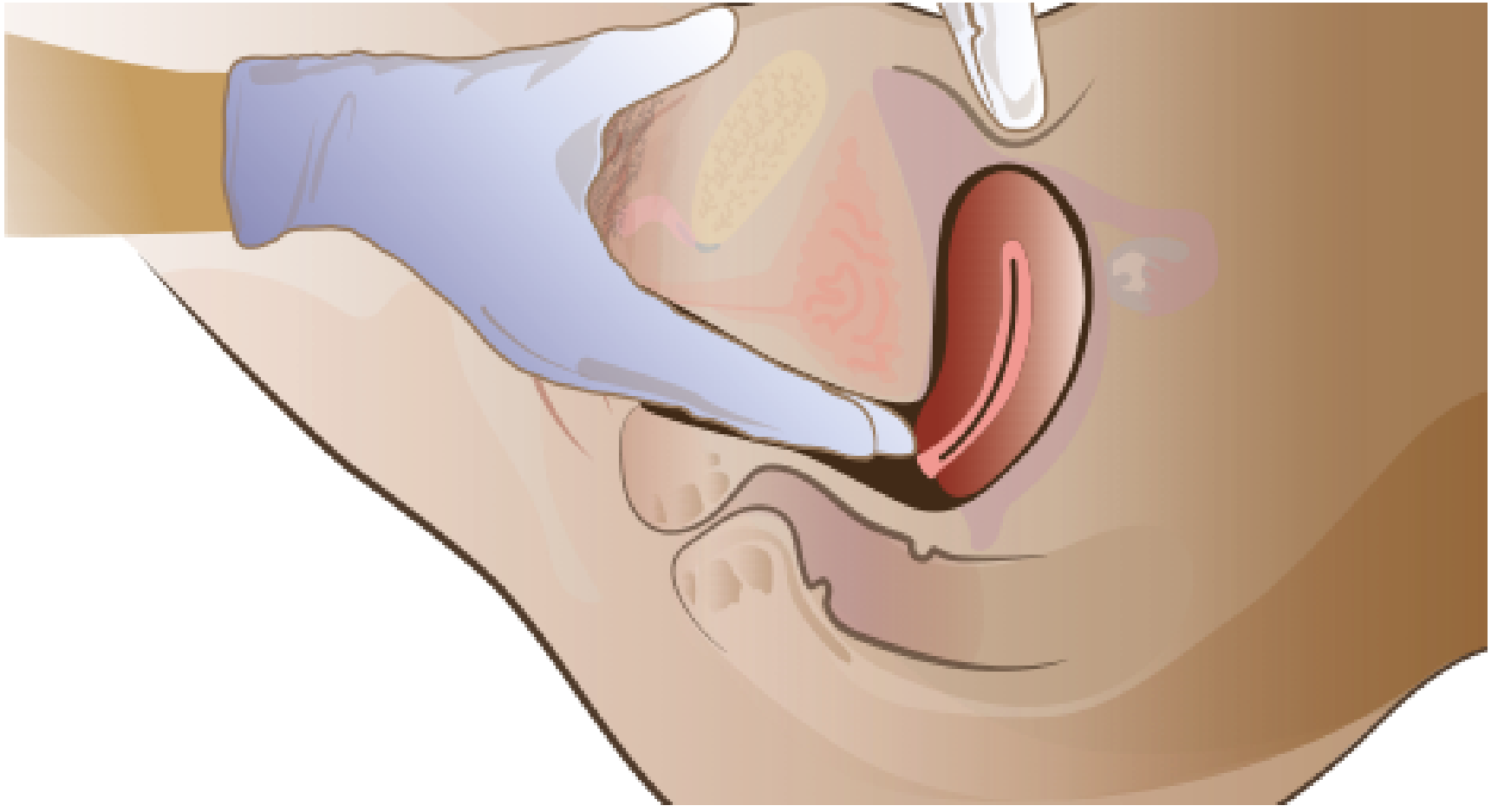


Imagen 22/29: Lineamientos_aborto.pdf-0106-15.png

Documento de origen: Lineamientos aborto

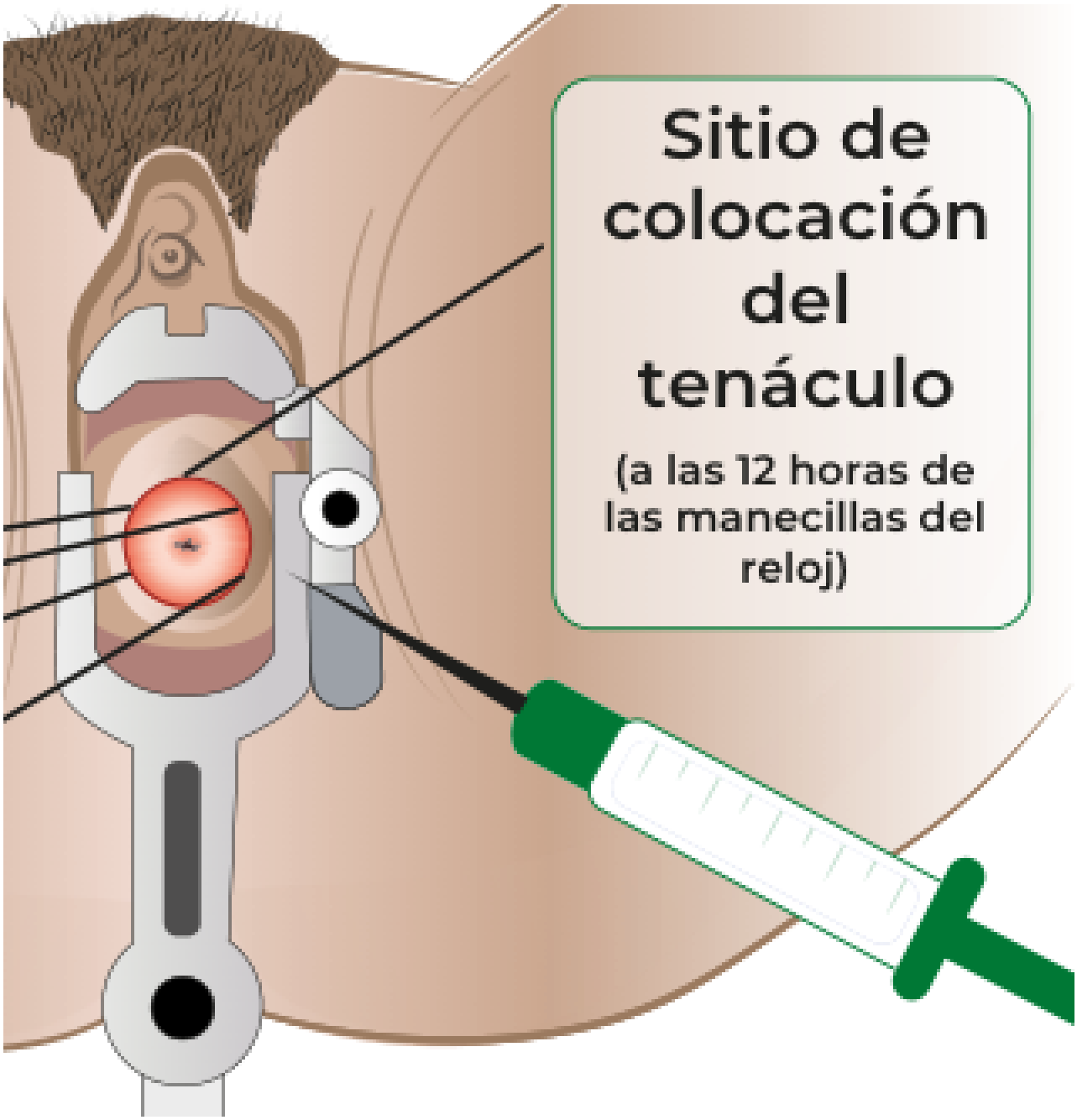


Imagen 23/29: Lineamientos_aborto.pdf-0107-08

Documento de origen: Linea

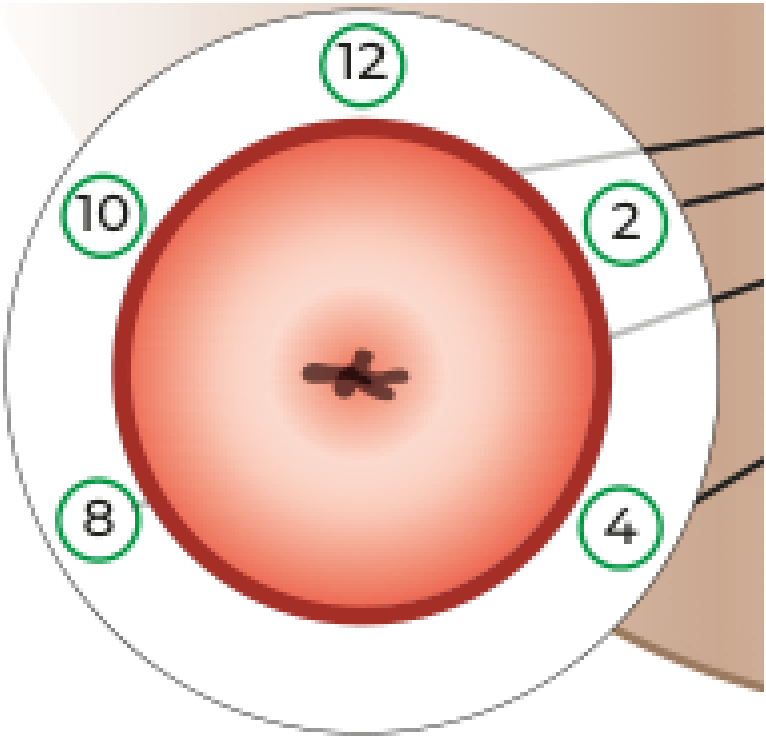


Imagen 24/29: Lineamientos_a

Documento de origen: Lineamientos aborto.pdf

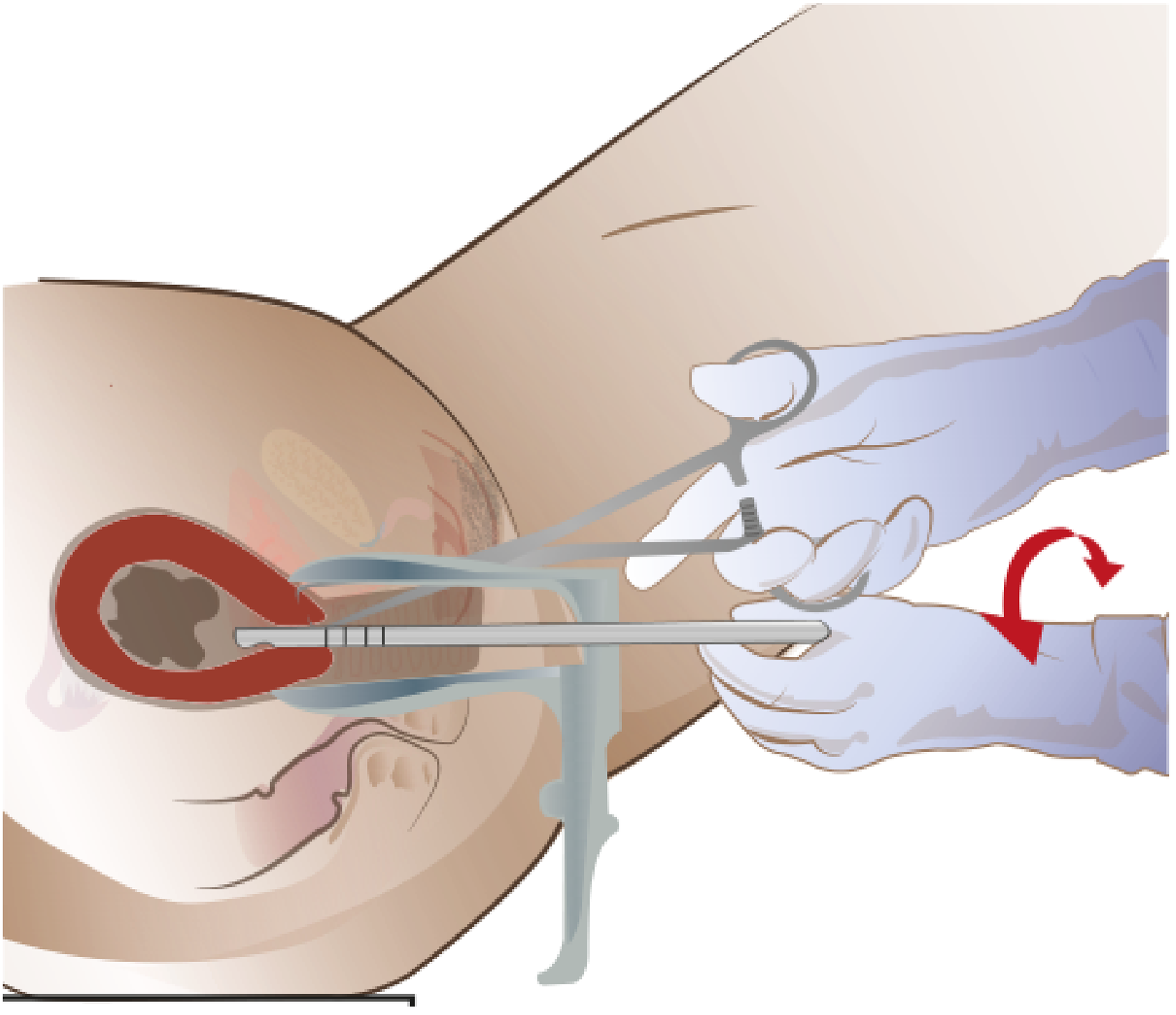


Imagen 25/29: Lineamientos_aborto.pdf-0108-02.png

Documento de origen: Linea

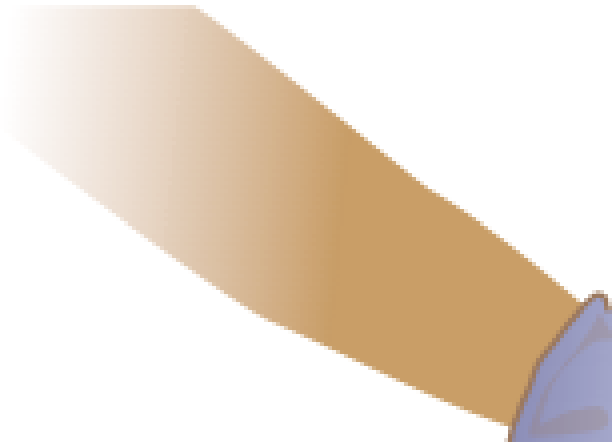
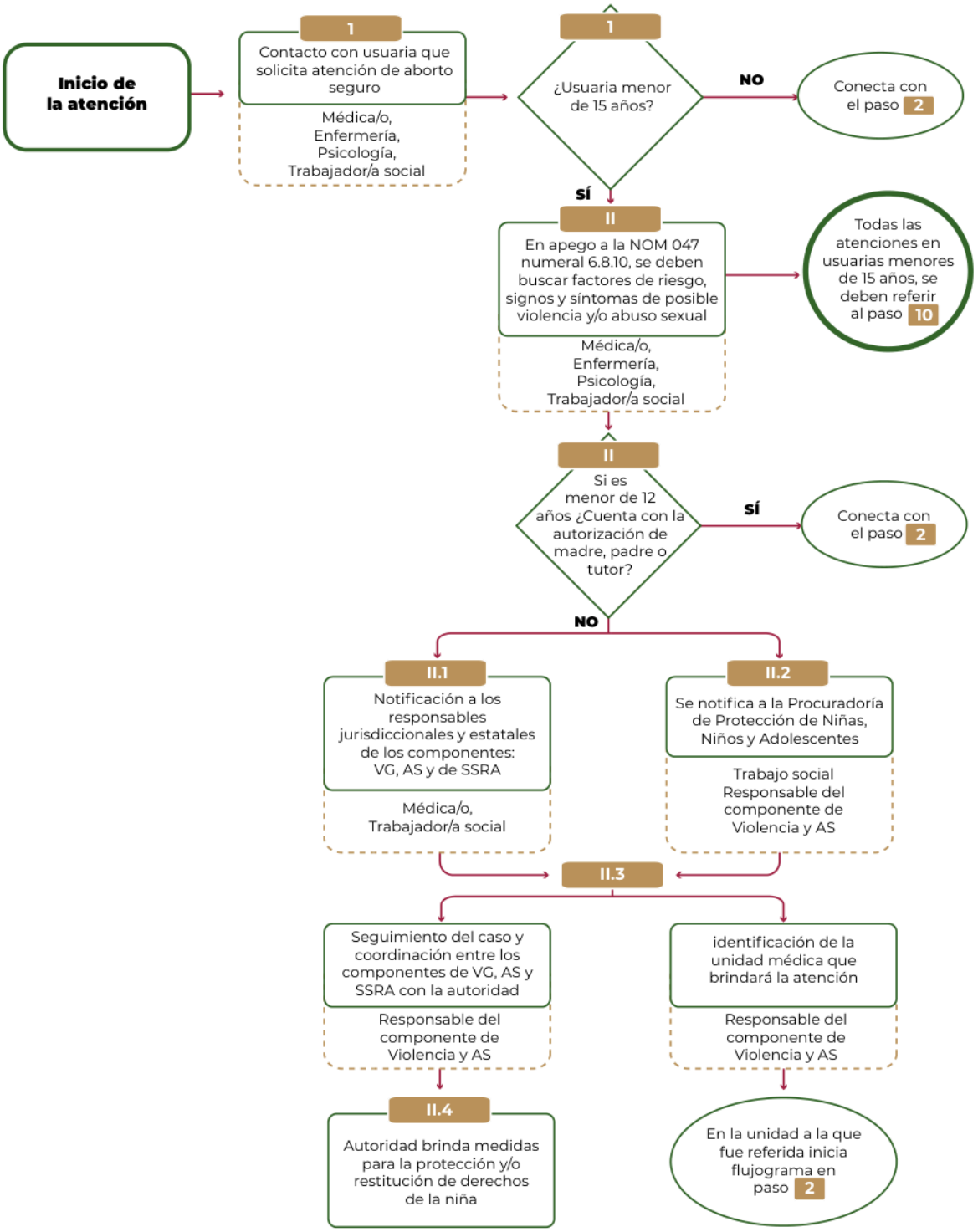
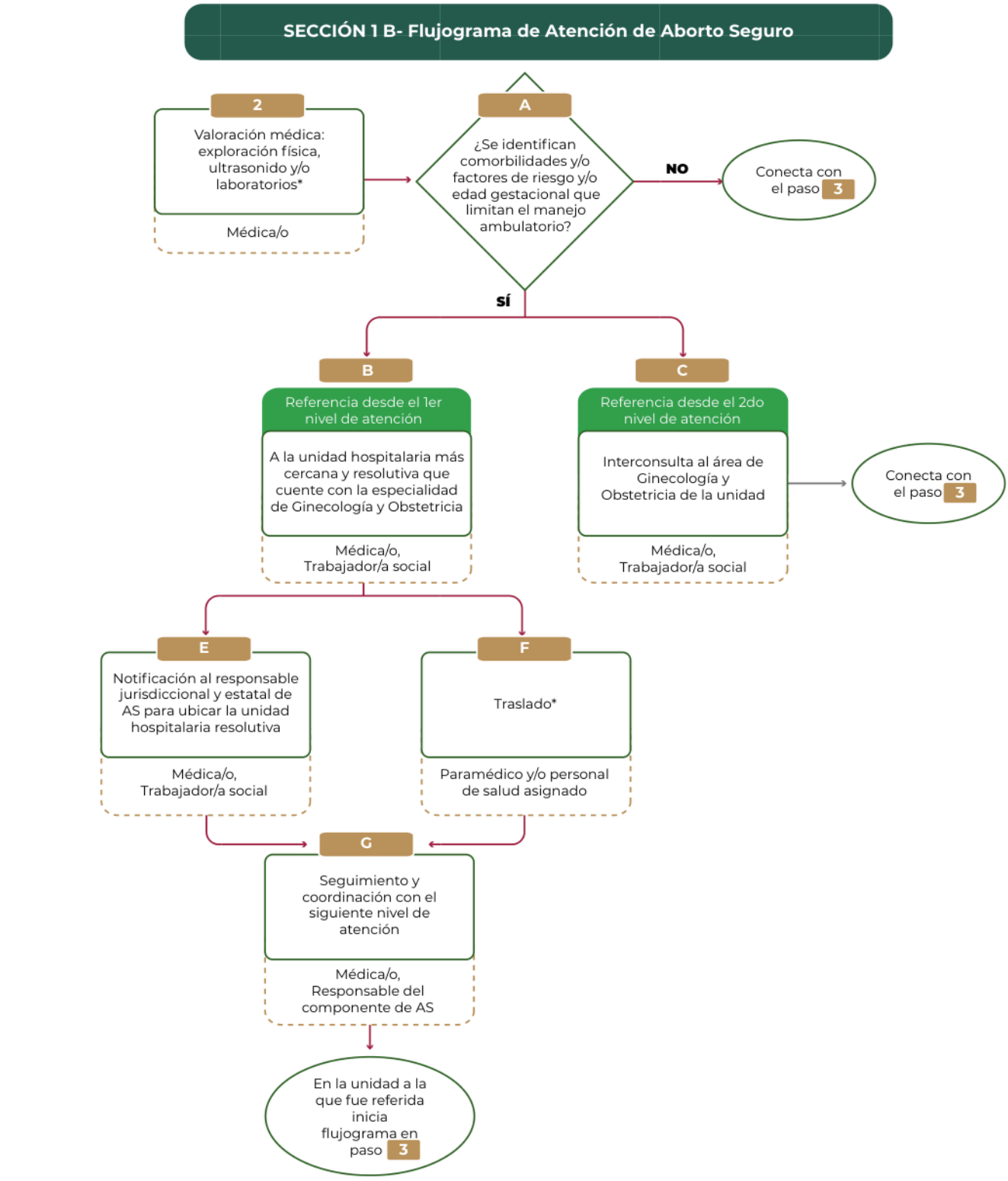


Imagen 26/29: Lineamientos_al


Inicio de la atención
1
Contacto con usuaria que solicita atención de aborto seguro
Médica/o, Enfermería, Psicología, Trabajador/a social
1
¿Usuaria menor de 15 años?
NO
Conecta con el paso 2
SÍ
II
En apego a la NOM 047 numeral 6.8.10, se deben buscar factores de riesgo, signos y síntomas de posible violencia y/o abuso sexual
Médica/o, Enfermería, Psicología, Trabajador/a social
Todas las atenciones en usuarias menores de 15 años, se deben referir al paso 10
II
Si es menor de 12 años ¿Cuenta con la autorización de madre, padre o tutor?
SÍ
Conecta con el paso 2
NO
II.1
Notificación a los responsables jurisdiccionales y estatales de los componentes: VG, AS y de SSRA
Médica/o, Trabajador/a social
II.2
Se notifica a la Procuradoría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Trabajo social Responsable del componente de Violencia y AS
II.3
Seguimiento del caso y coordinación entre los componentes de VG, AS y SSRA con la autoridad
Responsable del componente de Violencia y AS
identificación de la unidad médica que brindará la atención
Responsable del componente de Violencia y AS
II.4
Autoridad brinda medidas para la protección y/o restitución de derechos de la niña
En la unidad a la que fue referida inicia flujograma en paso 2


SECCIÓN 1 B- Flujograma de Atención de Aborto Seguro
2
Valoración médica: exploración física, ultrasonido y/o laboratorios*
Médica/o
A
¿Se identifican comorbilidades y/o factores de riesgo y/o edad gestacional que limitan el manejo ambulatorio?
NO
Conecta con el paso 3
SÍ
B
Referencia desde el 1er nivel de atención
A la unidad hospitalaria más cercana y resolutiva que cuente con la especialidad de Ginecología y Obstetricia
Médica/o, Trabajador/a social
C
Referencia desde el 2do nivel de atención
Interconsulta al área de Ginecología y Obstetricia de la unidad
Médica/o, Trabajador/a social
Conecta con el paso 3
E
Notificación al responsable jurisdiccional y estatal de AS para ubicar la unidad hospitalaria resolutiva
Médica/o, Trabajador/a social
F
Traslado*
Paramédico y/o personal de salud asignado
G
Seguimiento y coordinación con el siguiente nivel de atención
Médica/o, Responsable del componente de AS
En la unidad a la que fue referida inicia flujograma en paso 3

Documento de origen: Lineamientos aborto.pdf

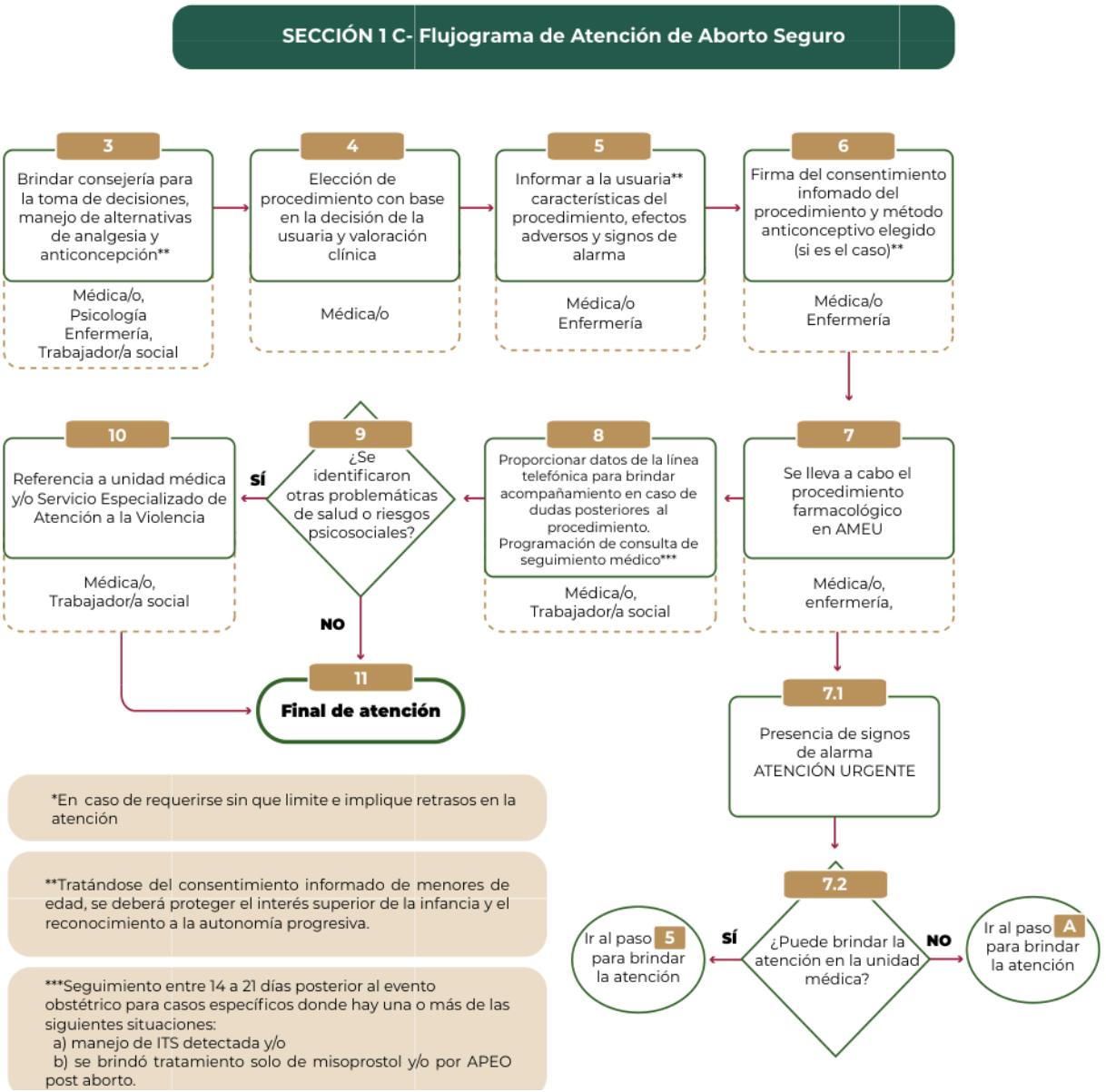


Imagen 29/29: Lineamientos_aborto.pdf-0117-04.png